

Obserwacja *ciała w sesji*

Sygnaly ciała wyprzedzają słowa — często zanim pacjent uświadomi sobie emocję. Oddech, napięcie, postawa, kontakt wzrokowy i kolor twarzy zdradzają afekt w czasie rzeczywistym.

CZAS: 20 min Każda sesja; pacjent werbalizujący mało afektu

ŹRÓDŁO: Davanloo (1990); Ogden i in. (2006)

JAK UŻYWAĆ

Śledzisz ciało pacjenta (ang. *somatic tracking*) jako stały nawyk: co 2-3 minuty „przelatujesz” wzrokiem oddech, napięcie, postawę. Obserwujesz **zmiany, nie stany** („w tym momencie ramiona się napięły” zamiast „jest napięty”), łączysz je z treścią, neutralnie nazywasz wybrane („zauważam, że oddech stał się płytszy”) i zapraszasz pacjenta do uwagi: „czy sama Pani to czuje?”.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Sygnaly somatyczne wyprzedzają świadomość — dają wskazówkę o afekcie, zanim pojawi się w słowach. ISTDP kładzie szczególny nacisk na ciało: obrony w ciele są równie ważne jak obrony w myśleniu. Typowe sygnaly: oddech (płytki = lęk, wstrzymany = tłumienie), napięcie (szczęka, pięści = złość lub lęk), postawa (skrzyżowane ręce = zamknięcie), kontakt wzrokowy (unikanie = wstyd), kolor twarzy (czerwień = wstyd/złość, bladość = lęk). Połączenie zmiany z treścią daje hipotezę o ukrytym afekcie.

01



Sześć obszarów obserwacji

Oddech — tempo, głębokość, wstrzymanie

Postawa — zamknięcie vs otwartość, dystans

Kolor twarzy — czerwień, bladość

Napięcie — ramiona, szczęka, pięści

Oczy — kontakt, unikanie, łzy

Głos — drżenie, tempo, pauzy

02



Łącz zmianę z treścią

Co mówi pacjent (lub co Ty mówisz), gdy zmiana ciała się pojawia? To daje hipotezę o afekcie. Zapisz zaobserwowaną zmianę i kontekst.

ZMIANA CIAŁA ↔ TREŚĆ W TYM MOMENCIE

03 © Nazwij i zaproś do uwagi

Neutralnie, bez interpretacji: „zauważam, że ramiona uniosły się”. Potem: „czy sama Pani to czuje? Co Pani zauważa?”. Poczekać — pacjent po chwili często uświadamia sobie afekt. Można zapytać: „co ciało chciałoby zrobić z tym napięciem?”.

JAK NAZWĘ OBSERWACJĘ I ZAPROSZĘ PACJENTA

04 ✕ Granica: dysocjacja

Jeśli pacjent „odpływa” (pustka w oczach, zamrożenie) — przerwij eksplorację somatyczną i wróć do ugruntowania: kontakt z podłogą, „tu i teraz”, nazwanie tego, co w pokoju. Zapisz swój plan na taką sytuację.

PLAN UGRUNTOWANIA PRZY DYSOCJACJI

Klucz: obserwacja ciała to umiejętność, która rośnie przez lata — początkujący widzą tylko oczywiste (płacz), zaawansowani wyłapują mikrozmiany (lekkie przesunięcie w fotelu, krótsze mruganie). Nagrania sesji i analiza w superwizji przyspieszają ten rozwój.